Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent9vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5163666-30.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: CINTIA UGHINI XAVIER DA COSTA

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

CINTIA UGHINI XAVIER DA COSTA ajuizou *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL* em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA,** partes já qualificadas. Narrou que possui um plano de saúde coletivo empresarial com a ré, e sofre de enxaqueca crônica (CID G43.9), condição que afeta sua capacidade de trabalho e vida diária, e que não respondeu aos tratamentos convencionais. Sustentou que, como alternativa, seu médico indicou o medicamento Fremanezumabe, que é um imunobiológico aprovado pela Anvisa e eficaz em reduzir suas crises. Referiu que o custo do tratamento perfaz R$ 1.166,80 por mês. Contudo, a ré recusou fornecer o medicamento, alegando que ele não está no rol de cobertura da ANS, ainda que o tratamento com imunobiológicos esteja contemplado pela norma. Argumentou que a recusa é contrária aos princípios de legalidade e razoabilidade, uma vez que a lei prevê a cobertura para sua condição, e que o tratamento é o único capaz de aliviar seu quadro. Postulou, em tutela de urgência, que a ré custeasse o medicamento, e no mérito, pelo reembolso das despesas já realizadas, no valor de R$3.165,00 (três mil, cento e sessenta e cinco reais) fundamentando seu pedido na obrigatoriedade legal de cobertura para doenças amparadas contratualmente.

Custas quitadas em **Evento 2.**

Deferida a tutela de urgência em **Evento 4.**

Citada, a ré contestou **(Evento 14).** Alegou que a negativa de cobertura do medicamento Fremanezumabe se justifica por não estar previsto para uso domiciliar em seu contrato de saúde, que é regulamentado pela Lei 9.656/98 e pelas resoluções da ANS. Referiu que, conforme o artigo 10 dessa lei, medicamentos para uso ambulatorial só seriam cobertos para uso domiciliar em casos de tratamento oncológico ou internação domiciliar, que não se aplicam ao caso. Aponta, ainda, a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que permite a exclusão desses medicamentos, reforçando a legitimidade da negativa com base no contrato e na legislação. Citou jurisprudência que valida a exclusão da cobertura para medicamentos domiciliares, reforçando que o plano de saúde não era obrigado a fornecer cobertura além do contratado. Afirmou que a exclusão desses medicamentos está de acordo com o princípio da mutualidade, fundamental para evitar desequilíbrio econômico e manter a viabilidade do contrato coletivo, além de assegurar a equidade entre os beneficiários do plano. Insurgiu-se ao reembolso de valores. Argumentou que não houve violação dos direitos da autora, pois as cláusulas contratuais eram claras, e a negativa de cobertura não configurava prática abusiva. Pediu improcedência à demanda.

Houve réplica **(Evento 17)**.

Intimadas a dizerem sobre o interesse na produção de provas, a autora postulou pela inversão do ônus da prova, e, caso fosse entendimento diverso o do Juízo, por prova pericial, e a ré requereu o julgamento da lide.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Considerando os limites aos quais se restringiu a controvérsia, dispensável a produção de outros meios de prova, o que autoriza o imediato julgamento da lide, no estado em que se encontra o processo (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

Narra a autora que é portadora de doença classificada no CID-10 G43.9, qual seja, Enxaqueca Crônica, devidamente comprovada por laudo médico, necessitando fazer uso mensal do medicamento AJOVY (*Fremanezumabe*) na dose de 225mg, via subcutânea, de modo a evitar complicações e agravamento em seu quadro.

Por tratar-se de medicação com custo elevado, buscou a ré para obter o custeio do tratamento. No entanto, recebeu parecer desfavorável, sob a alegação de que o medicamento prescrito não estava coberto pelo plano, conforme definição da ANS, se tratando de medicamento não oncológico, cujo tratamento ocorre fora da internação hospitalar, não possuindo cobertura conforme Resolução Normativa vigente (RN Nº 465, de 24 de fevereiro de 2021).

Nos contratos de plano de saúde, a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica de forma direta, conferindo proteção especial ao consumidor, que é considerado a parte mais vulnerável na relação contratual. O CDC estabelece que as cláusulas que importem em desvantagem exagerada para o consumidor, como as que excluem tratamentos indispensáveis para doenças cobertas, podem ser consideradas abusivas e, portanto, nulas de pleno direito (art. 51, IV).

Ademais, a aplicação do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, motivo que a operadora do plano de saúde tem o dever de demonstrar a legitimidade de sua conduta, especialmente ao negar a cobertura de tratamentos indicados para a condição da autora.

A ré, em defesa, comprovou que o medicamento, embora conste registrado na ANVISA, não faz parte do rol da ANS, bem como o fato da Lei 9.656/98, que rege os planos de saúde, excluir **explicitamente a cobertura obrigatória de medicamentos de uso domiciliar,** a menos que se trate de medicamentos para tratamento de câncer ou para substituição de internação hospitalar.

Conforme preconiza a RN 465/2021:

(...)

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998. Parágrafo único. ***São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: [...] VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para a administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;***

Subseção II

Do Plano Ambulatorial

Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os ***atendimentos*** *realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de* ***urgência e emergência****, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e* ***devendo garantir cobertura*** *para:*

(...)

*IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (****medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento****) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde;*

X - ***medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar,*** *assim como* ***medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso,*** *respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características:*

Ressalto que o medicamento ou insumo para tratamento domiciliar "***não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado*** *– é autoadministrado pelo paciente – e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar*" (REsp 1.927.566/RS, 3ª Turma, DJe 30/8/2021).

Vejamos o julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 2071955 - RS (2023/0151582-5), de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi:

"Sobre a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, previa a redação original da Lei 9.656/1998, no art. 10, VI, a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, sem exceções; vejamos:

Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;

A Resolução ANS 167/2008, que foi a primeira a regulamentar a cobertura – facultativa – de medicamentos de uso domiciliar, assim dispôs:

Art. 12. As operadoras de planos privados de assistência à saúde poderão oferecer, por sua iniciativa, cobertura maior do que a mínima obrigatória prevista nesta Resolução Normativa e seus Anexos, dentre elas, atenção domiciliar e assistência farmacêutica, inclusive medicação de uso oral domiciliar que substitua a terapia em regime hospitalar ou ambulatorial de cobertura obrigatória.

Em 2013, foi publicada a Lei 12.880/2013, que alterou a redação do art. 10, VI, e acrescentou as alíneas "c" ao inciso I e "g" ao inciso II, bem como os §§ 4º e 5º, ao art. 12, todos da Lei 9.656/1998, para incluir, no plano-referência, o custeio de medicamentos de uso domiciliar ***vinculados ao tratamento antineoplásico, nestes termos****:*

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

*VI - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12**; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)*

(...)

§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.

(...)

§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Vide Medida Provisória nº 1.665, de 1998) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

*Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, **respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:** (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

*c) **cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes**; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)*

(...)

*II - quando **incluir internação hospitalar**:*

(...)

*g) cobertura para **tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral,** procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja **relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar**; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)*

(...)

§ 4º As coberturas a que se referem as alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II deste artigo serão objeto de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, revisados periodicamente, ouvidas as sociedades médicas de especialistas da área, publicados pela ANS. (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)

§ 5º O fornecimento previsto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II deste artigo dar-se-á, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e de acordo com prescrição médica. (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)

A partir da Lei 9.656/1998 e das suas normas regulamentadoras, a Gerência de Assistência à Saúde da ANS editou o Parecer Técnico nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 (publicado em 01/04/2021) sobre as hipóteses de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar pelas operadoras de plano de saúde, do qual se extraem as seguintes conclusões:

*Cumpre assinalar que a Lei n.º 9.656/1998 deixa explícito, em seu artigo 10, inciso VI, que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar **não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias, exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso** (art. 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g"). Portanto, no que se refere a medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, **aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (art. 17, §1º, VI, da RN 465/2021), é obrigatória a cobertura para: a) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 18, inciso XI, da RN n.º 465/2021), respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN n.º 465/2021; e b) Medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da ANVISA e nas alíneas "d" e "g", do inciso II, do artigo 12, da Lei n.º 9.656/1998 c/c art. 13, da RN n.º 465/2021 c) Medicamentos que eventualmente constem em contrato ou aditivo contratual acordado entre as partes.** (Disponível em parecer_tecnico_no_20_2021_medicamentos_para_tratamento_domiciliar.pdf (www.gov.br), acesso em 08/20/2024 – grifou-se)*

A Resolução ANS 487/2022, que revogou a Resolução ANS 310/2012, e "dispõe sobre os princípios para a oferta de contrato acessório de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde", nestes termos:

Art. 3º As operadoras de planos de assistência à saúde poderão, facultativamente, ofertar a seus beneficiários contrato acessório de medicação de uso domiciliar, que deverá seguir os princípios estabelecidos na presente RN.

§ 1º Além do contrato acessório, a medicação de uso domiciliar poderá, também, ser ofertada aos beneficiários por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde.

§ 2º As regras disciplinadas nesta RN não se aplicam à oferta de medicação de uso domiciliar por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde.

*Está clara, portanto, a intenção do legislador, **expressa desde a edição da Lei 9.656/1998, de excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura obrigatória imposta às operadoras de plano de saúde**.*

Dessa forma, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998."

A jurisprudência, assim, **consolidou-se** no sentido de *ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde* (AgInt no REsp 1.890.823/SP, 4ª Turma, DJe 28/4/2022). No mesmo sentido: REsp 1.692.938/SP, 3ª Turma, DJe 4/5/2021).

Ademais, no que se refere a Lei nº 14.454/2022, que modificou o art. 10 da Lei nº 9.656/98, fixando critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estivessem incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, utilizando parâmetros semelhantes aos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para excepcionar a taxatividade do rol nos subitens ii e iii do item 4 da tese firmada no EREsp 1886929[1], registro que o NATJUS (NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO) se mostrou contrário a demandas similares, nos seguintes termos:

> *8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que a requerente apresenta critérios para cefaleia tipo Migrânea sem Aura/Migrânea Crônica pelo ICHD-3 (the internacional classification of headache disorders), segundo relatório médico; Considerando que já foi submetida a tratamentos de primeira e segunda linha, sem metrificação quanto a melhora apresentada e tempo de instituição da farmacoterapia; Considerando que há evidências sobre o uso do Fremanezumabe na terapia da cefaleia crônica com bons resultados, porém com eficácia modesta entre indivíduos com enxaqueca crônica refratária a duas ou mais medicações; Considerando a necessidade de mais estudos sobre a medicação para elucidar a relação entre a atividade farmacodinâmica e seu mecanismo; os riscos a longo prazo, especialmente no que diz respeito ao sistema cardiovascular; Considerando que não foram esgotadas as opções para tratamento de dor crônica no SUS, tais como amitriptilina, imipramina, gabapentina, carbamazepina; Considerando o alto custo do medicamento (vide item 2.13);* ***Considerando que a CONITEC não avaliou o medicamento pleiteado****; Considerando que as agências internacionais recomendaram o medicamento de acordo* ***com o cumprimento de critérios específicos e somente com redução importante no custo para se tornar custo-efetiva*** *(vide item 6);* ***Este NATJUS conclui como NÃO FAVORAVEL à demanda. (****TJDFT)*

No mesmo sentido, o NATJUS/RS:

> *Tecnologia: FREMANEZUMABE* ***Conclusão Justificada: Não favorável*** *Conclusão: Justifica-se o parecer desfavorável porque: 1. fremanezumabe mostrou benefício discreto no manejo de migrânea, com redução de cerca de 2 dias de dor ao mês e possibilidade de diminuição de eficácia no decorrer do tempo. 2. embora a migrânea do caso em tela não tenha exibido melhora importante em tratamento com múltiplos fármacos, seguem existindo inúmeras alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS. Ademais, destaca-se a existência, e eficácia, de tratamentos não-farmacológicos no tratamento de enxaqueca crônica, como medidas de higiene do sono e alimentação balanceada (1,5,7). 3. não há estudos mostrando a superioridade do fremanezumabe frente às inúmeras alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, somente a placebo. 4. apesar de se tratar de uma decisão isolada, deve-se ponderar o impacto orçamentário da utilização de fremanezumabe no manejo de migrânea, mesmo que refratária a tratamentos prévios. Por exemplo, em 2006, estudo de base populacional estimou que a migrânea acomete 10,7% da população de Pelotas (306.193 habitantes) (22). Apenas em Pelotas, se 2% das 32.763 pessoas com diagnóstico de enxaqueca necessitarem de tratamento profilático e se, dentre elas, 25% mostrar-se refratária ao tratamento inicial, tem-se que aproximadamente 165 pelotenses poderão demandar judicialmente fremanezumabe, representando o custo anual de R$ 3.553.275,00. Nessa linha, é digno de nota que uma agência de país de alta renda, como o Reino Unido, recomendou a incorporação desse tratamento apenas mediante redução significativa de preço. Há evidências científicas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não*

Por fim, agrego com jurisprudências no mesmo sentido:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARA MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. FREMANEZUMABE. ROL DA ANS, DE REGRA, TAXATIVO. AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA. 1. Segundo prevê a Lei nº 9.656/98, devem ser observadas as coberturas definidas na Resolução Normativa nº 465/01, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que apresenta as Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar. O rol de coberturas para os planos de saúde, em regra, é taxativo, conforme tese fixada pelo egrégio STJ nos autos do ERESP 1.886.929. 2. A Lei nº 9.656/98, quanto aos medicamentos e insumos de uso domiciliar, incluiu dentre as coberturas obrigatórias apenas aqueles destinados a tratamento antineoplásico,* ***sendo lícita a negativa da operadora****, uma vez que o medicamento é de uso domiciliar e não está incluídos nas exceções legais. 3. Ademais, o referido medicamento não está contemplado no rol da ANS, bem como não há circunstância excepcional justificadora de cobertura extra rol, além da existência de Notas Técnicas extraídas do sistema e-Natjus, ferramenta lançada para auxiliar na solução das controvérsias, como apoio ao judiciário, pelo CNJ e o Ministério da Saúde -, desfavoráveis à utilização. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 51382224720238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 27-07-2023)*
>
> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CEFALEIA CRÔNICA (MIGRÂNEA). MEDICAMENTO AJOVY® - FREMANEZUMABE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC. DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos insculpidos no art. 300 CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.* ***Não obstante o laudo médico, inviável seja determinado que a operadora do plano de saúde forneça medicamento objeto da lide, considerando que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliare****s; bem como ausente contratação acessória, e, ainda, inexistindo comprovação da eficácia do medicamento para a moléstia, não está demonstrada a probabilidade do direito alegado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 51015478520238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 27-07-2023)*
>
> *RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ENXAQUECA (CID-10 G43.9). PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO AJOVY - FREMANEZUMABE. FÁRMACO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. EXEGESE DO ART. 10, INC. VI, C/C ART. 12, INC. I, ALÍNEA "C" E INC. II, ALÍNEA "G", DA LEI Nº 9.656/98. RECUSA DE CUSTEIO. ROL DA ANS TAXATIVO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA* ***REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.*** *RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Inominado, Nº 51153900220228210001, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 18-10-2023)*
>
> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ENXAQUECA COMPLICADA. PEDIDO DE COBERTURA DO MEDICAMENTO FREMANEZUMABE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS QUE, EM REGRA, É TAXATIVO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1) É lícito que se excetue o fornecimento de tratamento domiciliar, quando não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, à exceção dos antineoplásicos. 2) A medicação Fremanezumabe não necessita de intervenção médica para aplicação, conforme se extrai da bula do medicamento, de modo que se ostenta lícita, em princípio, a exclusão de cobertura. 3) Após a Lei nº 14.454, sancionada em 21/09/2022 -, que estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, remanescem apenas duas das quatro condicionantes fixadas pelo STJ para excepcionar o rol da ANS, constantes nos itens "ii" e "iii" - (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina*

baseada em evidências; e ***(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros. 4) Ainda que haja recomendação médica de aplicação ambulatorial ou hospitalar do medicamento postulado, o que, a priori, afastaria a exclusão de cobertura atinente aos fármacos domiciliares, a negativa de cobertura justifica-se em razão da ausência de evidência científica ou recomendação por órgão de renome que torne aplicável os casos excepcionais incluídos pela Lei n.º 14.454/2022. 5) Outrossim, existem inúmeras Notas Técnicas (nº 118647, 142145, 140992, 140541, 161916), extraídas do sistema e-NATJUS, ferramenta lançada para auxiliar na solução das controvérsias, como apoio ao judiciário, pelo CNJ e o Ministério da Saúde -, desfavoráveis*** *ao uso do medicamento fremanezumabe para o tratamento de enxaqueca complicada. 6) Ausente probabilidade do direito da parte autora,* ***deve ser revogada a concessão da tutela de urgência.*** *DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 53831665320238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 29-02-2024)*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENXAQUECA CRÔNICA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR AJOVY (FREMANEZUMABE). AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. A LEI Nº 9.656/98, QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, EM SEU ART. 10, INCISO VI, PREVÊ A EXCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR DA COBERTURA ASSISTENCIAL MÉDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO PLANO-REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RESSALVANDO A HIPÓTESE DA NECESSIDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS AMBULATORIAIS E DOMICILIARES DE USO ORAL. NO CASO, O MEDICAMENTO, CUJO FORNECIMENTO SE PRETENDE AJOVY (FREMANEZUMABE), NÃO ESTÁ DENTRE AS EXCEÇÕES ARROLADAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, VISTO QUE SE ADMITE QUE O MEDICAMENTO NÃO SERÁ UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA, MAS PARA TRATAMENTO PREVENTIVO DE ENXAQUECA CRÔNICA. ***ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE OS PLANOS DE SAÚDE NÃO SÃO OBRIGADOS A FORNECER MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, EM HIPÓTESES COMO A DOS AUTOS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.****(Agravo de Instrumento, Nº 51006563020248217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiana Azevedo da Cunha Barth, Julgado em: 18-07-2024)*

-grifei.

Isso posto, revogo a tutela de urgência deferida e, com base no art. 487, I, do CPC, JULGO **IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por **CINTIA UGHINI XAVIER DA COSTA** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.**

A requerente arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, que fixo em R$ 1.200,00, forte no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o célere trâmite do feito, a desnecessidade de dilação probatória e a natureza da demanda.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIA MARIA PIRES TEDESCO, Juíza de Direito**, em 10/10/2024, às 21:32:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10069459349v15** e o código CRC **dd5d6622**.

---

1. § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) [grifei] ↩